أسئلة MCQ — تصوير عظم الفخذ

التصوير الشعاعي · نظري · 30 سؤال · الجواب الصحيح معلّم بـ ✓

1.

How many projections of the femur are listed in the lecture?

كم إسقاطاً لعظم الفخذ مذكوراً في المحاضرة؟

A) Four

أربعة

B) Five

خمسة

C) Six ✓ الجواب الصحيح

ستة

D) Eight

ثمانية

💡 قائمة المسقطات فيها ستة إسقاطات: ثلاثة للورك والجزء القريب، وثلاثة لجسم الفخذ.

2.

The axiolateral inferosuperior projection is listed for:

الإسقاط الجانبي المحوري السفلي العلوي مذكور لـ:

A) Hip and proximal femur—trauma ✓ الجواب الصحيح

الورك والجزء القريب من الفخذ في الإصابات

B) Femur—mid- and distal

الجزء الأوسط والبعيد من الفخذ

C) Knee joint only

مفصل الركبة فقط

D) Pelvic inlet

مدخل الحوض

💡 قائمة المسقطات: الإسقاط الجانبي المحوري السفلي العلوي للورك والجزء القريب من الفخذ في الإصابات.

3.

Which structure is found on the femoral head?

أيّ تركيب يوجد على رأس عظم الفخذ؟

A) Adductor tubercle

حديبة المقرِّبة

B) Intercondylar fossa

الحفرة بين اللقمتين

C) Fovea capitis ✓ الجواب الصحيح

نُقرة رأس الفخذ

D) Popliteal surface

السطح المأبضي

💡 رسم الجزء القريب من عظم الفخذ: نُقرة الرأس (Fovea capitis) على الرأس.

4.

Which structure connects the greater and lesser trochanters posteriorly?

أيّ تركيب يصل بين المدوَّرين الكبير والصغير من الخلف؟

A) Femoral neck

عنق عظم الفخذ

B) Intertrochanteric crest ✓ الجواب الصحيح

العرف بين المدوَّرين

C) Fovea capitis

نُقرة رأس الفخذ

D) Medial epicondyle

فوق اللقمة الإنسية

💡 المنظر الخلفي للجزء القريب: العرف بين المدوَّرين بين المدوَّر الكبير والصغير.

5.

Which structures are found at the distal end of the femur?

أيّ تراكيب توجد في الطرف البعيد لعظم الفخذ؟

A) Greater and lesser trochanters

المدوَّران الكبير والصغير

B) Head and neck

الرأس والعنق

C) Medial and lateral condyles ✓ الجواب الصحيح

اللقمتان الإنسية والوحشية

D) Fovea capitis

نُقرة رأس الفخذ

💡 رسم عظم الفخذ من الخلف: اللقمتان وفوق اللقمتين والحفرة بين اللقمتين في الطرف البعيد.

6.

What exposure is listed for the femur?

ما عوامل التعرّض المذكورة لعظم الفخذ؟

A) 70-80 kVp, 20-30 mAs

70–80 kVp، و20–30 mAs

B) 50-55 kVp, 2-4 mAs

50–55 kVp، و2–4 mAs

C) 100-110 kVp, 1-2 mAs

100–110 kVp، و1–2 mAs

D) 65-70 kVp, 8-12 mAs ✓ الجواب الصحيح

65–70 kVp، و8–12 mAs

💡 عوامل التعرّض في المحاضرة: 65–70 kVp، و8–12 mAs.

7.

Why is close collimation important in CR or DR of the femur?

لماذا التسديد الضيّق مهم في التصوير المحوسب أو الرقمي لعظم الفخذ؟

A) To prevent fogging from scatter radiation ✓ الجواب الصحيح

لمنع التضبيب الناتج عن الإشعاع المتشتّت

B) To increase the SID

لزيادة المسافة SID

C) To reduce the exposure time only

لتقليل زمن التعرّض فقط

D) To include the knee joint

لشمول مفصل الركبة

💡 المحاضرة: التسديد الضيّق مهم فوق الأجزاء غير المعرّضة من IR لمنع التضبيب من الإشعاع المتشتّت.

8.

Where is the lead shield placed for the femur?

أين يوضَع الدرع الرصاصي في تصوير عظم الفخذ؟

A) Over the knee joint

فوق مفصل الركبة

B) Over the chest only

فوق الصدر فقط

C) Under the IR

تحت مستقبِل الصورة

D) Over the gonadal area, down to midfemur level ✓ الجواب الصحيح

فوق منطقة الغدد التناسلية حتى منتصف الفخذ

💡 التدريع: ضع درعاً رصاصياً فوق منطقة الغدد التناسلية، ومُدّه إلى مستوى منتصف عظم الفخذ.

9.

For the AP unilateral hip, the affected leg is rotated internally:

في إسقاط الورك AP من جانب واحد، تُدوَّر الساق المصابة للداخل:

A) 5°

5 درجات

B) 45°

45 درجة

C) 30° to 35°

30 إلى 35 درجة

D) 15° to 20° **الجواب الصحيح ✓**

15 إلى 20 درجة

💡 وضعية الجزء: دوّر الساق المصابة للداخل 15° إلى 20°.

10.

Where is the CR directed for the AP unilateral hip?

إلى أين يُوجَّه الشعاع المركزي في إسقاط الورك AP؟

A) 1 to 2 inches (2.5 to 5 cm) distal to midfemoral neck **الجواب الصحيح ✓**

1 إلى 2 إنش (2.5 إلى 5 سم) أسفل منتصف عنق الفخذ

B) To the iliac crest

إلى العرف الحرقفي

C) To the symphysis pubis

إلى الارتفاق العاني

D) To the knee joint

إلى مفصل الركبة

💡 الشعاع المركزي عمودي على IR، ويُوجَّه 1–2 إنش (2.5–5 سم) أسفل منتصف عنق الفخذ.

11.

How can the femoral neck be located?

كيف يُحدَّد موضع عنق عظم الفخذ؟

A) At the level of the iliac crest

عند مستوى العرف الحرقفي

B) 3-5 cm medial and 8-10 cm distal to ASIS

الجواب الصحيح ✓

3–5 سم إنسيّ و8–10 سم أسفل ASIS

C) 2 cm above the symphysis pubis

2 سم فوق الارتفاق العاني

D) At the level of the ischial tuberosity

عند مستوى الحدبة الإسكية

💡 المحاضرة: عنق الفخذ نحو 1–2 إنش (3–5 سم) إنسيّ و3–4 إنش (8–10 سم) أسفل ASIS.

12.

Which part of the femur should be visualized on the AP hip?

أيّ جزء من عظم الفخذ يجب أن يظهر في إسقاط الورك AP؟

A) The distal one-third

الثلث البعيد

B) The entire femur

عظم الفخذ كله

C) The proximal one-third

الجواب الصحيح ✓

الثلث القريب

D) Only the femoral head

رأس الفخذ فقط

💡 ما تُظهره الصورة: الثلث القريب من عظم الفخذ مع الحُقّ والأجزاء المجاورة.

13.

The axiolateral inferosuperior projection is also called:

يُسمّى الإسقاط الجانبي المحوري السفلي العلوي أيضاً:

A) Clements-Nakayama method

طريقة كليمنتس-ناكاياما

B) Danelius-Miller method ✓ الجواب الصحيح

طريقة دانيليوس-ميلر

C) Judet method

طريقة جوديه

D) Taylor method

طريقة تايلور

عنوان الإسقاط في المحاضرة: الجانبي المحوري السفلي العلوي، طريقة دانيليوس-ميلر.

14.

In the Danelius-Miller method, the unaffected leg is:

في طريقة دانيليوس-ميلر، الساق السليمة:

A) Extended on the table

تُمدّ على الطاولة

B) Placed on the x-ray tube

توضَع على أنبوب الأشعة

C) Flexed and elevated near vertical ✓ الجواب الصحيح

تُثنى وتُرفع قريباً من العمودي

D) Rotated internally 15°

تُدوَّر للداخل 15 درجة

وضعية الجزء: اثنِ الساق السليمة وارفعها بحيث يكون الفخذ قريباً من العمودي وخارج حقل التسديد.

15.

In the Danelius-Miller method, the IR is placed:

في طريقة دانيليوس-ميلر، يوضَع مستقبِل الصورة:

A) Parallel to the femoral neck and perpendicular to CR

موازياً لعنق الفخذ وعمودياً على الشعاع

الجواب الصحيح ✓

B) Perpendicular to the femoral neck

عمودياً على عنق الفخذ

C) Flat under the pelvis

مسطّحاً تحت الحوض

D) Parallel to the CR

موازياً للشعاع المركزي

💡 ضع IR في الثنية فوق العرف الحرقفي وعدّله ليكون موازياً لعنق الفخذ وعمودياً على الشعاع المركزي.

16.

Why should the leg NOT be placed on the collimator or x-ray tube?

لماذا يجب ألا توضَع الساق على المُسدِّد أو أنبوب الأشعة؟

A) It increases scatter radiation

تزيد الإشعاع المتشتّت

B) Risk of burns or electrical shock

خطر الحروق أو الصدمة الكهربائية

الجواب الصحيح ✓

C) It causes grid cutoff

تسبّب قطع الشبكة

D) It foreshortens the femoral neck

تقصّر عنق الفخذ

💡 المحاضرة: لا تضع الساق على المُسدِّد أو الأنبوب لخطر الحروق أو الصدمة الكهربائية.

17.

The modified axiolateral projection is known as:

يُعرف الإسقاط الجانبي المحوري المعدّل بـ:

A) Danelius-Miller method

طريقة دانيليوس-ميلر

B) Clements-Nakayama method ✓ الجواب الصحيح

طريقة كليمنتس-ناكاياما

C) Modified Cleaves method

طريقة كليفز المعدّلة

D) Judet method

طريقة جوديه

💡 عنوان الإسقاط في المحاضرة: الجانبي المحوري المعدّل، طريقة كليمنتس-ناكاياما.

18.

In the Clements-Nakayama method, the CR is angled posteriorly from horizontal by:

في طريقة كليمنتس-ناكاياما، يُمال الشعاع إلى الخلف عن الأفقي بمقدار:

A) 15° to 20° ✓ الجواب الصحيح

15 إلى 20 درجة

B) 40°

40 درجة

C) 5°

5 درجات

D) 30° to 45°

30 إلى 45 درجة

💡 الشعاع المركزي: يجب أن يُمال للخلف 15° إلى 20° عن الأفقي.

19.

In the Clements-Nakayama method, the leg is kept:

في طريقة كليمنتس-ناكاياما، تبقى الساق:

A) Rotated internally 15° to 20°

مُدارة للداخل 15 إلى 20 درجة

B) In neutral (anatomic) position — **الجواب الصحيح ✓**

في الوضع المحايد (التشريحي)

C) Flexed 90° and elevated

مثنية 90 درجة ومرفوعة

D) Abducted 45°

مُبعَدة 45 درجة

💡 وضعية الجزء: أبقِ الساق في الوضع المحايد؛ إمالة الشعاع 15° للخلف تعوّض عن تدوير الساق.

20.

Why is the face of the IR kept perpendicular to the CR in the modified axiolateral?

لماذا يُبقى وجه مستقبِل الصورة عمودياً على الشعاع في الإسقاط المعدّل؟

A) To prevent fogging

لمنع التضبيب

B) To prevent grid cutoff — **الجواب الصحيح ✓**

لمنع قطع الشبكة

C) To reduce patient dose

لتقليل جرعة المريض

D) To include the knee

لشمول الركبة

💡 وضعية الجزء: أمِل IR نحو 15° وعدّله ليكون عمودياً على الشعاع لمنع قطع الشبكة.

21.

For a true AP of the mid- and distal femur, the leg is rotated internally about:

للحصول على AP حقيقي للجزء الأوسط والبعيد من الفخذ، تُدوَّر الساق للداخل نحو:

A) 5°

الجواب الصحيح ✓

5 درجات

B) 15° to 20°

15 إلى 20 درجة

C) 45°

45 درجة

D) 90°

90 درجة

💡 وضعية الجزء: دوّر الساق للداخل نحو 5° لـ AP حقيقي، كما في AP الركبة.

22.

For the AP mid- and distal femur, the lower IR margin should be:

في AP للجزء الأوسط والبعيد من الفخذ، الحافة السفلى لمستقبِل الصورة تكون:

A) At the level of the knee joint

عند مستوى مفصل الركبة

B) At the ankle

عند الكاحل

C) About 2 inches (5 cm) below the knee joint

الجواب الصحيح ✓

نحو 2 إنش (5 سم) أسفل مفصل الركبة

D) At the ASIS

عند ASIS

💡 المحاضرة: الحافة السفلى لـ IR نحو 2 إنش (5 سم) أسفل مفصل الركبة.

23.

Why will the knee joint space not appear fully open on the AP femur?

لماذا لا تظهر مسافة مفصل الركبة مفتوحة بالكامل في AP الفخذ؟

A) Because of grid cutoff

بسبب قطع الشبكة

B) Because the knee is flexed 45°

لأن الركبة مثنية 45 درجة

C) Because of divergent x-ray beam ✓ الجواب الصحيح

بسبب تباعد حزمة الأشعة

D) Because of patient breathing

بسبب تنفّس المريض

💡 ما تُظهره الصورة: مسافة مفصل الركبة لا تظهر مفتوحة بالكامل بسبب تباعد حزمة الأشعة.

24.

For the lateral recumbent mid- and distal femur, the knee is flexed about:

في الإسقاط الجانبي بالاستلقاء الجانبي للجزء الأوسط والبعيد، تُثنى الركبة نحو:

A) 45° ✓ الجواب الصحيح

45 درجة

B) 90°

90 درجة

C) 15°

15 درجة

D) 5°

5 درجات

💡 وضعية الجزء: اثنِ الركبة نحو 45° والمريض على جانبه المصاب.

25.

Why is the unaffected leg placed behind the affected leg?

لماذا توضَع الساق السليمة خلف الساق المصابة؟

A) To include the hip joint

لشمول مفصل الورك

B) To reduce scatter radiation

لتقليل الإشعاع المتشتّت

C) To support the IR

لدعم مستقبِل الصورة

D) To prevent over-rotation ✓ الجواب الصحيح

لمنع الدوران الزائد

💡 المحاضرة: ضع الساق السليمة خلف المصابة لمنع الدوران الزائد.

26.

In the trauma lateromedial projection of the femur, the beam is:

في الإسقاط الوحشي الإنسي للإصابات، يكون الشعاع:

A) Horizontal, directed from the lateral side ✓ الجواب الصحيح

أفقياً، من الجهة الوحشية

B) Vertical, directed from above

عمودياً، من الأعلى

C) Angled 40° caudad

مائلاً 40 درجة للقدمين

D) Horizontal, from the medial side

أفقياً، من الجهة الإنسية

💡 المحاضرة: ضع IR على حافته ملاصقاً للجهة الإنسية من الفخذ، مع شعاع أفقي من الجهة الوحشية.

27.

When should the lateral recumbent position NOT be attempted?

متى يجب ألا تُجرى وضعية الاستلقاء الجانبي؟

A) If the patient is an adult

إذا كان المريض بالغاً

B) If the knee joint must be included

إذا لزم شمول الركبة

C) If a grid is used

إذا استُعملت شبكة

D) If the patient has severe trauma ✓ الجواب الصحيح

إذا كان المريض مصاباً إصابة شديدة

التحذير: لا تحاول هذه الوضعية إذا كان المريض مصاباً إصابة شديدة.

28.

For the lateral mid- and proximal femur, the patient rolls back (posteriorly) about:

في الإسقاط الجانبي للجزء الأوسط والقريب، يميل المريض إلى الخلف نحو:

A) 45°

45 درجة

B) 5°

5 درجات

C) 90°

90 درجة

D) 15° ✓ الجواب الصحيح

15 درجة

وضعية الجزء: اطلب من المريض أن يميل للخلف نحو 15° لمنع التراكب.

29.

Where is the upper IR margin placed for the lateral mid- and proximal femur?

أين توضَع الحافة العليا لمستقبِل الصورة في الإسقاط الجانبي للجزء الأوسط والقريب؟

A) At the level of the knee

عند مستوى الركبة

B) At the level of the ASIS ✓ الجواب الصحيح

عند مستوى ASIS

C) At the iliac crest + 5 cm

فوق العرف الحرقفي بـ 5 سم

D) At the midshaft of femur

عند منتصف جسم الفخذ

💡 المحاضرة: جُسّ ASIS وضع الحافة العليا لـ IR عند مستوى هذا المعلم.

30.

For the lateral mid- and proximal femur, the patient lies:

في الإسقاط الجانبي للجزء الأوسط والقريب، يستلقي المريض:

A) Supine with legs extended

على ظهره والساقان ممدودتان

B) Prone

على بطنه

C) Lateral, affected side up

على جانبه، والجانب المصاب للأعلى

D) Lateral recumbent, affected side down ✓ الجواب الصحيح

على جانبه، والجانب المصاب للأسفل

💡 وضعية المريض: الاستلقاء الجانبي والجانب المصاب إلى الأسفل.